

O INSTRUCTOR

Quem conduz este módulo



1º TEN QOCBM
GERALDO

1º Tenente Geraldo

Oficial Bombeiro Militar — Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE)



FORMAÇÃO

Engenharia Química —
Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE)



ESPECIALIZAÇÃO

Pós-graduação em
Atendimento Pré-Hospitalar
(APH)



ATUAÇÃO

Especialista em APH e
Resgate Operacional

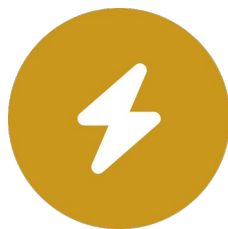
ESCOPO DO MÓDULO

Quatro emergências que alteram a consciência — e o que o público geral deve fazer



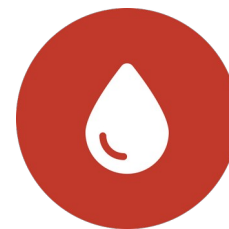
SÍNCOPE (DESMAIO)

Perda breve da consciência por queda do fluxo de sangue ao cérebro. Recupera sozinha.



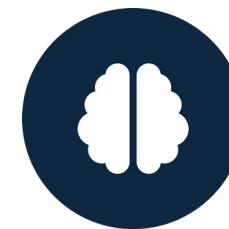
CRISE CONVULSIVA

Descarga elétrica anormal no cérebro, com abalos musculares. Proteger sem conter.



HIPOGLICEMIA

Açúcar baixo no sangue: suor frio, tremor e confusão. Pode evoluir para convulsão.



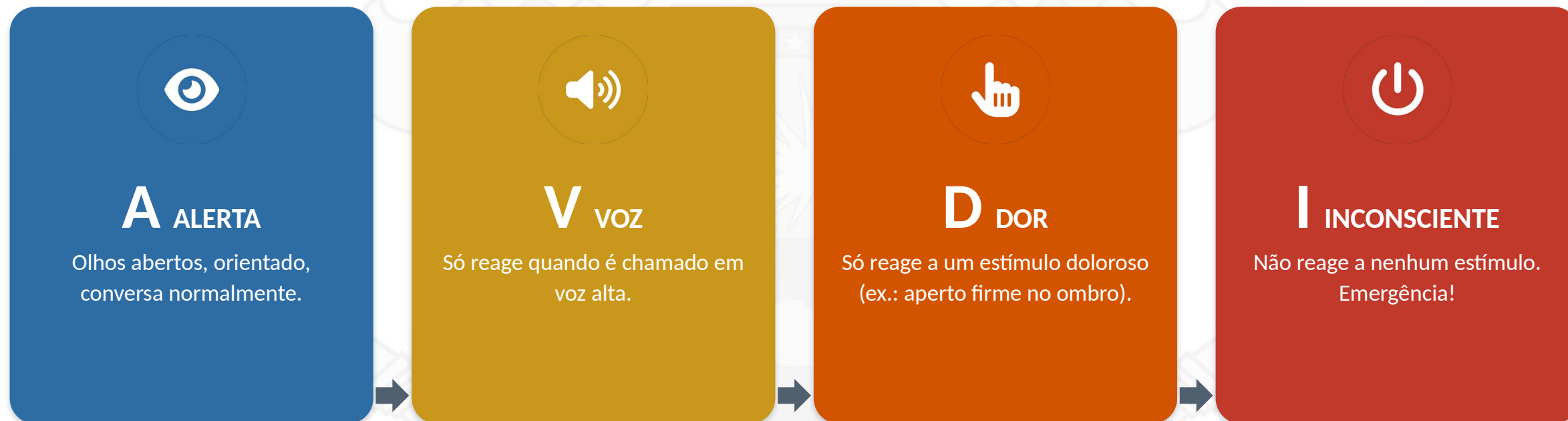
AVC

Interrupção súbita da circulação no cérebro. Cada minuto conta.

Objetivo do módulo: reconhecer, proteger e acionar — 193 (Bombeiros) • 192 (SAMU). Linguagem para o público geral, sem treinamento.

NÍVEL DE CONSCIÊNCIA: ESCALA AVDI

Avaliação rápida usada no pré-hospitalar — quanto mais à direita, mais grave



E a Escala de Coma de Glasgow?

Pontua de 3 a 15 a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora — é ferramenta de profissionais. Para o público geral basta uma pergunta: a vítima responde ou não responde? E respira normalmente?

PRIMEIRA ABORDAGEM EM 4 PASSOS

Vale para qualquer pessoa caída ou com a consciência alterada



1 CENA SEGURA

Trânsito, fogo, fios, multidão:
proteja-se primeiro.



2 RESPONDE?

Toque firme nos ombros e
chame em voz alta.



3 RESPIRA?

Observe o tórax subir e descer
por até 10 segundos.



4 ACIONE

193 ou 192 no viva-voz. Siga as
orientações.

NÃO responde e NÃO respira normalmente

(ou só “puxa o ar” de forma irregular) → 192/193, inicie a RCP e peça um DEA.

Não responde, mas RESPIRA normalmente

→ Posição Lateral de Segurança, acione o socorro e reavalie a respiração até a chegada.

COMO DIFERENCIAR NA PRÁTICA

Pistas que qualquer pessoa consegue observar

Situação	Como começa	O que se vê	Recuperação	Conduta-chave
Síncope	Súbito, após calor, jejum, dor, susto ou muito tempo em pé	Palidez, suor frio, queda “mole”; abalos breves ou ausentes	Rápida e espontânea (em geral < 1 min)	Deitar, elevar as pernas ~30 cm, afrouxar roupas
Crise convulsiva	Súbito; pode haver grito, queda e rigidez	Abalos rítmicos, salivação; pode urinar ou morder a língua	Lenta: confusão e sono após a crise	Proteger, cronometrar, PLS após os abalos
Hipoglicemia	Em minutos; diabético em uso de insulina ou comprimidos	Tremor, fome, suor frio, confusão, fala “embolada”	Só melhora com açúcar	Acordado: açúcar pela boca. Sonolento: nada pela boca, 192
AVC	Súbito, a qualquer hora e lugar	Boca torta, fraqueza de um lado, fala alterada	Não melhora sozinho — o tempo agrava	SAMU: anotar a hora e ligar 192

 **Na dúvida, trate como grave:** acione 192 (SAMU) ou 193 (Bombeiros) e observe a respiração.

SÍNCOPE (DESMALTO): O QUE É

Perda súbita e breve da consciência, com recuperação espontânea

Por que acontece?

O fluxo de sangue para o cérebro cai por alguns segundos: a pessoa perde a consciência e o tônico e cai. Deitada, o sangue volta ao cérebro e ela recupera.

DURAÇÃO TÍPICA

SEGUNDOS

Recuperação espontânea e completa, em geral em menos de 1 minuto. Se demorar mais, NÃO trate como desmaio simples → 192.

Causas comuns (síncope vasovagal)



Calor intenso e sol forte



Desidratação



Jejum prolongado



Estresse, dor, susto ou ver sangue



Muito tempo em pé (formaturas, filas)

ANTES DE DESMAIAR: SINAIS DE AVISO

Reconhecer a pré-síncope permite evitar a queda



Sinais de aviso

- Palidez e suor frio
- Tontura, “vista escurecendo” ou turva
- Náusea, mal-estar, calorão súbito
- Bocejos e fraqueza nas pernas
- Zumbido no ouvido

Ao primeiro sinal:

1

Sente-se ou deite-se imediatamente, em local seguro. Evita a queda e o trauma na cabeça.

2

Manobras de contrapressão: cruzar as pernas contraindo coxas e glúteos, agachar-se, ou entrelaçar as mãos e puxar os braços.

3

Não melhorou? deite-se de costas e eleve as pernas; peça ajuda.

CONDUTA CORRETA NO DESMAIO

Posicionar, liberar e observar



roupas afrouxadas



1

Deite a vítima de costas em local seguro e plano.

2

Eleve as pernas ~30 cm (cadeira, mochila, capacete).

3

Afrouxe roupas apertadas: gola, cinto, gravata.

4

Garanta ventilação: sombra e curiosos afastados.

5

Ao acordar, mantenha deitada alguns minutos antes de sentar.



Vomitou ou não acordou em ~1 minuto?

Vire a vítima em Posição Lateral de Segurança e ligue 192.

QUANDO NÃO É “SÓ UM DESMAIO”

Qualquer um destes sinais: ligue 192 sem esperar



Não recupera a consciência em ~1 minuto



Dor no peito ou palpitações antes da queda



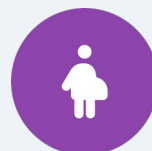
Desmaiou durante esforço físico ou deitado



Falta de ar ou respiração anormal



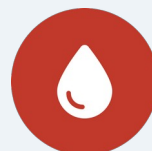
Ferimento na queda, principalmente na cabeça



Gestante



Convulsão, confusão persistente ou sinais de AVC



Idoso, cardiopata ou diabético

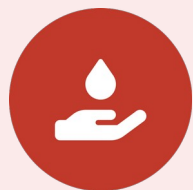
O QUE NUNCA FAZER NO DESMAIO

Condutas populares que causam dano



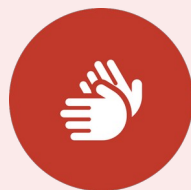
Álcool ou amônia para cheirar

Irrita as vias aéreas e
não “acorda” ninguém.



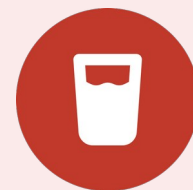
Jogar água no rosto

Risco de aspiração e de
nova queda.



Sacudir ou dar tapas

Pode agravar lesões da
queda.



Líquido ou comida com a vítima sonolenta

Risco de
broncoaspiração fatal.



Levantar à força

O sangue volta a faltar
no cérebro: novo
desmaio.

Broncoaspiração: por que é tão perigosa?

Com a consciência rebaixada, os reflexos de engolir e tossir falham: líquido ou alimento vai para o pulmão, podendo sufocar ou causar pneumonia grave. Nada pela boca até a vítima estar totalmente acordada.

CRISE CONVULSIVA: O QUE É

Atividade elétrica anormal no cérebro — em geral para sozinha em poucos minutos

1 FASE TÔNICA

Rigidez do corpo e queda; pode haver grito e respiração irregular.



2 FASE CLÔNICA

Abalos rítmicos de braços e pernas, salivação; pode urinar ou morder a língua.



3 PÓS-CRISE

Confusão, sonolência e cansaço por minutos a horas. Maior risco de aspiração.

Causas frequentes

- Epilepsia
- Febre alta em crianças de 6 meses a 5 anos (convulsão febril)
- Hipoglicemia, traumatismo craniano, AVC
- Intoxicações e abstinência de álcool

Convulsão febril na criança

Mesmas condutas de proteção. Não dar banho frio, não passar álcool e não dar remédio pela boca durante a crise. Terminada a crise, levar para avaliação médica.



CONVULSÃO: O QUE FAZER

Proteger sem conter — a crise não se interrompe à força



cronometre a crise

proteja a cabeça



afaste objetos



1

Mantenha a calma: afaste curiosos e objetos duros ou cortantes.

2

Proteja a cabeça com almofada, casaco ou mochila; retire óculos.

3

Afrouxe roupas no pescoço. NÃO segure braços e pernas.

4

Cronometre: anote o início e a duração da crise.

5

Após os abalos: Posição Lateral de Segurança e fique ao lado até acordar.

Por que lateralizar só DEPOIS?

Virar ou segurar durante os abalos machuca a vítima e quem ajuda. Quando os movimentos param, a PLS deixa saliva e vômito escorrerem para fora.

O CRONÔMETRO DECIDE: QUANDO LIGAR 192

A maioria das crises para sozinha — estas situações exigem socorro

CRISE COM MAIS DE

5 MIN

Ligue 192 imediatamente: risco de crise prolongada (estado de mal epiléptico).



Ligue 192 também se:



Crises seguidas, sem acordar entre elas



Primeira crise da vida



Dificuldade para respirar após a crise



Ferimento durante a queda



Gestante ou pessoa com diabetes



A crise aconteceu na água

MITOS PERIGOSOS NA CONVULSÃO

O “socorro” popular que mais causa lesões



NADA DENTRO DA BOCA

Nem mão, pano, colher, caneta ou carteira.

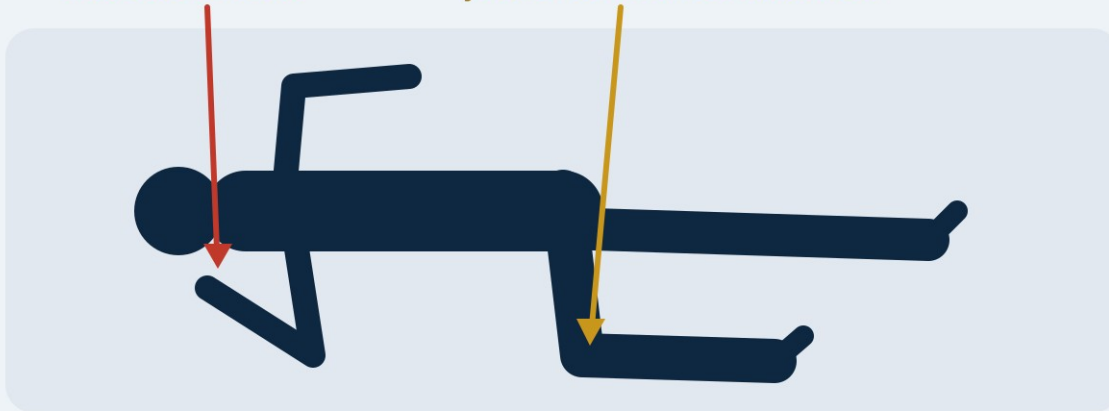
A língua não enrola.

MITO	VERDADE
“Desenrolar a língua” para não sufocar	A língua não enrola. Objetos na boca quebram dentes, podem ser aspirados e amputam dedos do socorrista.
Segurar braços e pernas	Nada interrompe a crise à força. Conter causa fraturas e luxações na vítima e lesões em quem ajuda.
Jogar água, dar álcool ou amônia	Não interrompe a crise e aumenta o risco de aspiração e de trauma.
Dar água ou remédio logo após	Nada pela boca até a vítima estar totalmente acordada: risco de broncoaspiração.
Convulsão “pega” pela saliva	Epilepsia não é contagiosa. Ajudar não traz risco.

POSIÇÃO LATERAL DE SEGURANÇA (PLS)

Para a vítima que respira, mas não está totalmente acordada

mão sob o rosto joelho de cima dobrado a 90°



Reavalie a respiração o tempo todo

Se parar de respirar normalmente: vire de costas, acione 192/193 e inicie RCP.

1

Ajoelhe-se ao lado. Coloque o braço mais próximo em ângulo reto.

2

Cruze o outro braço sobre o peito, com o dorso da mão junto à bochecha.

3

Dobre o joelho do lado oposto e, puxando por ele, role a vítima para o seu lado.

4

Deixe o joelho a 90°, incline levemente a cabeça para trás, boca voltada para baixo.

HIPOGLICEMIA: O AÇÚCAR QUE FALTA AO CÉREBRO

Mais comum em diabéticos que usam insulina ou comprimidos

GLICEMIA ABAIXO DE

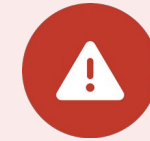
70 mg/dL

Referência da SBD. Pode evoluir em minutos para convulsão e coma.



SINAIS INICIAIS

- Tremor, suor frio, palidez
- Fome intensa, coração acelerado
- Ansiedade e irritação



SINAIS GRAVES

- Confusão, fala “embolada”, jeito de “bêbado”
- Sonolência e desmaio
- Convulsão

Quem está em risco

- Diabético que atrasou ou pulou refeição
- Excesso de insulina ou exercício intenso
- Consumo de álcool

Atenção: pode ser confundida com embriaguez

Pergunte se é diabético; procure pulseira ou cartão de identificação, glicosímetro ou insulina nos pertences.

HIPOGLICEMIA: O QUE FAZER

Tudo depende de uma pergunta: a vítima consegue engolir com segurança?

ACORDADA E ENGOLE BEM → REGRA DOS 15



15 g de açúcar rápido

1 colher de sopa de açúcar em meio copo de água, ou 150 mL de suco ou refrigerante comum (não diet).



Aguarde 15 minutos

e reavalie. Sem melhora: repita a dose.



Melhorou?

Ofereça um lanche e oriente procurar o médico.



Piorou ou não melhora?

Ligue 192.

SONOLENTA, CONFUSA OU INCONSCIENTE

NADA pela boca — nem água com açúcar, nem bala: risco de broncoaspiração.

- Se respira: Posição Lateral de Segurança.
- Ligue 192 imediatamente e informe que é diabético.
- Se parar de respirar normalmente: RCP.



AVC: TEMPO É CÉREBRO

Interrupção súbita da circulação em parte do cérebro

ISQUÊMICO

Um coágulo entope um vaso do cérebro. É a maioria dos casos (cerca de 85%).

HEMORRÁGICO

Um vaso se rompe e sangra dentro do cérebro. Costuma ser mais grave.

A CADA MINUTO SEM TRATAMENTO

~1,9 milhão

de neurônios perdidos, em média (estimativa clássica de Saver, Stroke 2006). Tempo é cérebro.

Por que anotar a hora?

No hospital, o tratamento depende do tempo desde o início dos sintomas (ou da última vez em que a pessoa foi vista bem). O trombolítico, por exemplo, só pode ser usado nas primeiras horas.



RECONHEÇA O AVC: MNEMÔNICO SAMU

Teste de 1 minuto que qualquer pessoa pode aplicar



S SORRISO

Peça para sorrir. Um lado da boca ficou torto ou caído?



A ABRAÇO

Peça para erguer os dois braços, como num abraço. Um braço cai ou não sobe?



M MENSAGEM

Peça para repetir uma frase simples. A fala sai enrolada, trocada ou não entende?



U URGÊNCIA

Ligue 192 imediatamente e anote a hora do início dos sintomas.

Basta UM sinal alterado para ligar 192 — mesmo que o sinal melhore em seguida.

AVC: ENQUANTO O SAMU NÃO CHEGA

Observar, proteger e informar

X NÃO FAÇA

- Não dar água, comida ou remédios (nem para pressão, nem AAS).
- Não esperar “passar” nem mandar para casa descansar.
- Não deixar a vítima sozinha.
- Prefira o 192 a levar por conta própria: o SAMU encaminha ao hospital preparado.



✓ FAÇA

- Anote a hora do início dos sintomas (ou quando foi vista bem pela última vez).
- Acordada: repouso, deitada com a cabeça levemente elevada.
- Vomitou ou ficou sonolenta: Posição Lateral de Segurança.
- Separe documentos e a lista de remédios em uso.



Informe ao 192: hora do início • sinais observados • remédios em uso • doenças conhecidas

RESUMO: DECISÃO RÁPIDA

Da cena segura à conduta certa

Vítima com alteração da consciência → cena segura? responde? respira normalmente?



Caiu e acordou rápido

Deitar, pernas elevadas ~30 cm, afrouxar roupas, ventilar.



Abalos musculares

Proteger a cabeça, cronometrar, nada na boca. PLS depois.



Diabético, suor frio, confuso

Engole bem: açúcar (regra dos 15).
Sonolento: nada pela boca, 192.



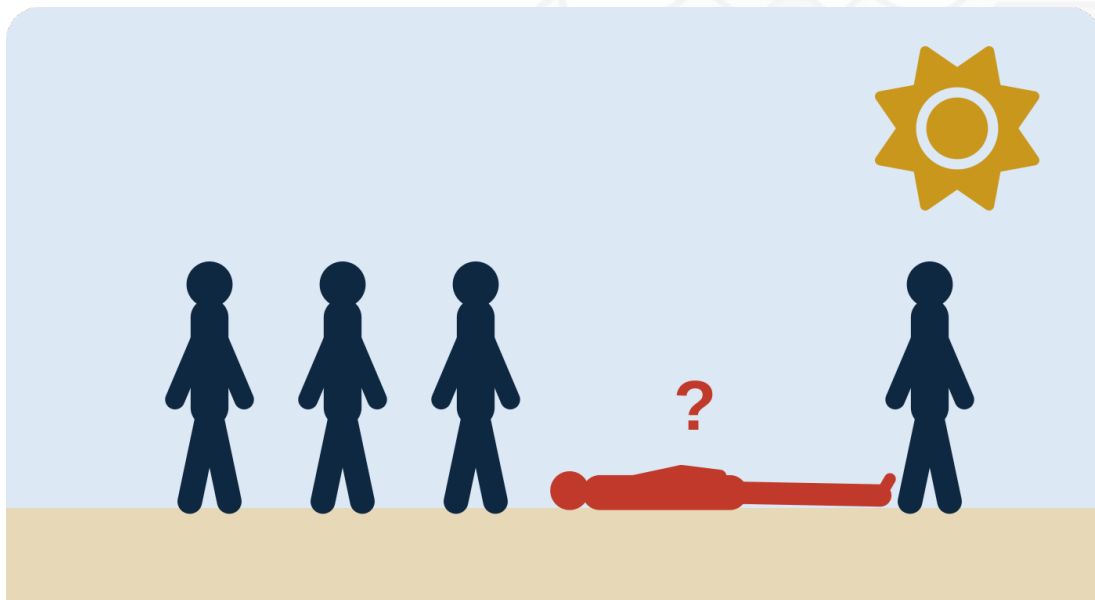
Boca torta, braço fraco, fala alterada

SAMU: anotar a hora e ligar 192.

Não responde e não respira normalmente? 192 / 193 + RCP + DEA

CASO 1: DESMAIO NA FORMATURA

Como corrigir a conduta dos companheiros?



CENÁRIO

Formatura sob sol forte. Um jovem fica pálido, sua frio e desmaia. Os companheiros tentam colocá-lo de pé à força e dar água com açúcar. Como corrigir?

✗ O QUE ESTÁ ERRADO

- Levantar à força: falta sangue no cérebro de novo → novo desmaio e queda.
- Água com açúcar com a vítima sonolenta: risco de broncoaspiração.

✓ CONDUTA CORRETA

- Deitar à sombra, de costas, com as pernas elevadas ~30 cm.
- Afrouxar gandola e cinto; afastar a tropa para ventilar.
- Líquidos só quando estiver bem acordado e sentado.
- Não acordou em ~1 min ou bateu a cabeça → 192.

CASO 2: CONVULSÃO EM PRAÇA PÚBLICA

Como agir com autoridade e técnica?



CENÁRIO

Na praça, uma pessoa cai com movimentos involuntários e salivação. Populares seguram os braços e tentam abrir a boca com o cabo de uma colher. Como agir?

✗ O QUE ESTÁ ERRADO

- Segurar os braços: não para a crise e causa fraturas e luxações.
- Colher na boca: quebra dentes, pode ser aspirada e fere quem ajuda.

✓ CONDUTA CORRETA

- Assuma com voz calma e firme: “Soltem os braços e se afastem”.
- Delegue: “Você, ligue 192. Você, marque o tempo”.
- Proteja a cabeça e afaste objetos; nada na boca.
- Acabou a crise: PLS e acompanhe. Passou de 5 min → 192.

QUIZ — QUESTÃO 1 DE 5

Discuta com a turma antes de ver o gabarito



Um colega fica pálido e desmaia durante uma formatura sob sol forte. Qual a conduta correta para o público geral?

A

Colocá-lo de pé rapidamente para “reanimar” a circulação.

B

Deitá-lo de costas, elevar as pernas cerca de 30 cm e afrouxar as roupas.

C

Oferecer água com açúcar enquanto ainda está sonolento.

D

Dar álcool ou amônia para ele cheirar.

QUIZ — QUESTÃO 2 DE 5

Discuta com a turma antes de ver o gabarito



Durante uma crise convulsiva, o que NUNCA deve ser feito?

A

Proteger a cabeça com um casaco ou almofada.

B

Afastar objetos duros e cortantes.

C

Colocar uma colher ou pano na boca para “desenrolar a língua”.

D

Cronometrar a duração da crise.

QUIZ — QUESTÃO 3 DE 5

Discuta com a turma antes de ver o gabarito



Em que momento a vítima de convulsão deve ser colocada em Posição Lateral de Segurança?

A

Assim que começam os abalos, segurando braços e pernas.

B

Após o término dos abalos, se estiver respirando.

C

Somente quando o socorro chegar.

D

Nunca: ela deve permanecer de costas.

QUIZ — QUESTÃO 4 DE 5

Discuta com a turma antes de ver o gabarito

?

Um diabético está confuso, suando frio e sonolento, com dificuldade para engolir. O que fazer?

A

Dar água com açúcar em grande quantidade.

B

Colocar açúcar na boca e fazê-lo beber água.

C

Não dar nada pela boca, colocar em PLS e ligar 192.

D

Deixá-lo dormir: é apenas cansaço.

QUIZ — QUESTÃO 5 DE 5

Discuta com a turma antes de ver o gabarito



No mnemônico SAMU para reconhecer o AVC, o que significa a letra “U”?

A

Usar o remédio de pressão da vítima imediatamente.

B

Urgência: ligar 192 e anotar a hora do início dos sintomas.

C

Unir as mãos da vítima para testar a força.

D

Umedecer a boca da vítima com água.

GABARITO COMENTADO (1 A 3)

Respostas fundamentadas nas diretrizes oficiais

Q1 • B

Deitá-lo de costas, elevar as pernas cerca de 30 cm e afrouxar as roupas.

Deitar e elevar as pernas devolve sangue ao cérebro. Levantar à força provoca novo desmaio; líquidos com a vítima sonolenta e álcool ou amônia aumentam o risco de broncoaspiração e lesões.

Q2 • C

Colocar uma colher ou pano na boca para “desenrolar a língua”.

A língua não enrola. Objetos na boca quebram dentes, podem ser aspirados e ferem o socorrista. Proteger a cabeça, afastar objetos e cronometrar são condutas corretas.

Q3 • B

Após o término dos abalos, se estiver respirando.

Durante os abalos não se contém nem se move a vítima. Terminada a crise, a PLS mantém as vias aéreas livres de saliva e vômito.

GABARITO COMENTADO (4 E 5)

Respostas fundamentadas nas diretrizes oficiais

Q4 • C

Não dar nada pela boca, colocar em PLS e ligar 192.

Quem não engole com segurança não recebe nada pela boca (risco de broncoaspiração). Açúcar oral é só para a vítima acordada e capaz de engolir — regra dos 15.

Q5 • B

Urgência: ligar 192 e anotar a hora do início dos sintomas.

Sorriso, Abraço, Mensagem, Urgência. A hora do início dos sintomas define as opções de tratamento no hospital. Nada pela boca, nem remédios.

Regra de ouro do módulo

Alteração da consciência = nada pela boca, proteger de lesões, manter as vias aéreas livres e acionar 193/192. Na dúvida, trate como grave.

PONTOS-CHAVE

O que cada pessoa deve levar para casa



Desmaio

Deitar, elevar as pernas ~30 cm, afrouxar roupas. Nunca levantar à força.



Convulsão

Proteger a cabeça, afastar objetos, cronometrar. Nada na boca.



PLS

Depois dos abalos ou na vítima que respira mas não acorda.



Hipoglicemia

Engole bem: açúcar (regra dos 15).
Sonolento: nada pela boca.



AVC

Sorriso, Abraço, Mensagem, Urgência.
Anote a hora.



Na dúvida

193 (Bombeiros) • 192 (SAMU). Ligue cedo.

REFERÊNCIAS

Fontes científicas e institucionais consultadas

Fonte	Acesso
American Heart Association / Cruz Vermelha Americana — First Aid Guidelines 2024 (síncope e responsividade)	ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001292
Ministério da Saúde / SAMU 192 — Suporte Básico de Vida em emergências clínicas	gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/samu-192
Liga Brasileira de Epilepsia (LBE) — Primeiros socorros na crise convulsiva	epilepsia.org.br/primeiros-socorros
NAEMT — PHTLS, 10ª edição: avaliação do nível de consciência e Escala de Glasgow	Material de referência do curso (PDF institucional)
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) — Manejo da hipoglicemia aguda	diabetes.org.br
Saver JL. Time is brain — quantified. Stroke, 2006;37:263-266	Estimativa de perda neuronal no AVC

